

PROPOSTA - FILACLARA - GCETENS843

PROPOSTA DE SOLUÇÃO — FILAS INTELIGENTES EM SERVIÇOS DE SAÚDE COM FOCO EM ACESSIBILIDADE

Documento VIVO — Aberto para edição coletiva

Responsáveis principais: Ausiane + Rios (pesquisa + proposta)

Última atualização: 12/06/2026 (22:20) — Problema real de Rios totalmente integrado + fluxo de ação imediata para o grupo colocado logo após a explicação expandida + Painel de Decisões ancorado + checklist completo no final

Status: Em construção — **Problema real escrito e integrado** (base oficial de Rios). Pronto para o grupo revisar, marcar decisões e sugerir alterações.

Nome do arquivo: proposta.md

O que é este projeto? (Explicação expandida para alinhamento do grupo)

1. O Problema Real que Estamos Resolvendo

Base formal e completa (12/06/2026):

Contextualização fundamentada em literatura elaborada por Rios.

 Leia na íntegra: [problema-real.md](#)

(Fonte original: `material-fonte/Projeto-Algorithm-1-Rios-2026-06-12.docx`)

Pergunta central do projeto (Rios):

Como reduzir o tempo de permanência física dos usuários nas unidades de saúde e aumentar a previsibilidade do atendimento por meio de uma solução digital acessível e inclusiva?

Nome da solução: FilaClara  (definido em enquete encerrada em 25/06/2026)

Sugestões da enquete: FilaAcessível (Deivison), Sistema Inteligente de Gestão de Filas Presenciais e Acessibilidade (Rios), Minha Fila (Marcos Vinícius). **Vencedor: FilaClara.**

Resumo executivo do problema (baseado no texto de Rios):

O fluxo atual em serviços de saúde de porta aberta (UBS, UPA, pronto-socorro, clínicas) é:

1. Pessoa chega → guichê → senha física (ordem de chegada).
2. Aguarda na sala de espera.
3. Depende de chamadas por alto-falante ou painéis com códigos opacos (“AB-22”, “H-27”).
4. Não sabe posição exata, nem tempo estimado.
5. Pessoas com deficiência auditiva perdem a chamada.
6. Baixa visão não lê o painel.

7. TEA sofre com barulho, imprevisibilidade e falta de informação clara.

8. Idosos, gestantes e acompanhantes ficam ansiosos sem poder sair.

Consequências (fundamentadas na literatura citada por Rios): - Sensação de injustiça e falta de transparência (“estão passando na frente”). - Redução de satisfação e percepção negativa da qualidade (Aggarwal et al., 2022). - Aglomeração, estresse, absenteísmo, falhas de comunicação (Thompson et al., 2023). - Barreiras graves para PCD, idosos e crônicos (Clemente et al., 2022; Farias et al., 2023; Ha et al., 2023; Jonsson et al., 2023). - Necessidade de permanência física excessiva na unidade. - O Protocolo de Manchester (cores de risco) só entra **depois** da triagem — entre guichê e triagem existe um “buraco” de informação.

O problema não é novo e projetos anteriores não resolveram de forma satisfatória (Melo et al., 2021; Giannotti; Louvison; Chioro, 2025).

Conclusão da problematização (Rios):

É necessário desenvolver soluções tecnológicas que promovam **maior eficiência na gestão das filas presenciais**, reduzam o tempo de permanência física e garantam **acessibilidade para todos**.

2. O que o App Propõe Ser

O **FilaClara** é um sistema de acompanhamento de filas em tempo real focado em **transparência + acessibilidade**.

Ideia central: - O paciente chega, faz um cadastro rápido (ou importa do Meu SUS Digital). - O sistema mostra, no celular da pessoa: - Sua posição atual na fila. - Tempo estimado de espera (atualizado em tempo real). - Quantas pessoas estão na frente e suas cores de risco (sem mostrar nomes). - Notificação quando estiver próximo de ser chamado. - O paciente pode **sair do local** (ir ao banheiro, dar uma volta, tomar café) e ser avisado quando faltar pouco. - Tudo tem versões acessíveis: alto contraste, texto grande, modo silencioso/visual para surdos, modo baixo estímulo para TEA.

Não é um sistema que substitui a triagem oficial. É uma **camada de transparência e acolhimento** que existe **antes e durante** o processo.

3. Como o App Pode Funcionar na Prática (Visão de Alto Nível)

Jornada básica do paciente (versão mais simples que podemos prototipar):

1. **Chegada** → Abre o app ou escaneia QR Code da recepção.
2. **Cadastro rápido** (nome, CPF ou cartão SUS, telefone, se tem alguma deficiência ou necessidade especial).
3. **Recebe senha virtual** + entra na fila.
4. **Acompanha no celular:**

◦ “Você está em 7º lugar”

- “Tempo estimado: 38 minutos”
- “3 pessoas na sua frente são Verde, 2 são Amarelo”

5. **Recebe notificação** quando faltarem 2-3 pessoas.
6. **Vai para triagem** quando for chamado.
7. (Opcional) Depois da consulta, recebe resumo com orientações.

O que a equipe de saúde vê (painel interno): - Lista ordenada por chegada + cor de risco. - Botão para chamar o próximo. - Histórico de quem já passou.

4. Por Que Isso é Diferente de Sistemas Existentes

A maioria dos sistemas de fila atuais: - Só mostram número na tela física. - Não têm acessibilidade real (pessoas com deficiência visual/auditiva/TEA ficam desassistidas). - Não permitem que a pessoa saia do local sem perder a vez. - Não mostram transparência sobre quem está na frente (gera sensação de injustiça).

Nosso diferencial (diretamente derivado da problematização de Rios):

- **Acessibilidade como pilar central** (modos para TEA, surdos, baixa visão, idosos, gestantes, com impacto no fluxo e na interface).
- **Transparência radical** (posição real + tempo estimado atualizado + cores de risco das pessoas à frente, sem nomes).
- **Mobilidade** (poder sair do local e receber notificação quando estiver próximo).
- **Redução do tempo de permanência física** na unidade (previsibilidade permite que o usuário planeje melhor a espera).

Isso responde diretamente à pergunta central: reduzir permanência física e aumentar previsibilidade por meio de solução digital **acessível e inclusiva**.

Como usar este documento (formato visual de decisão)

1. Leia toda a explicação expandida acima primeiro (importante para todo mundo estar alinhado).
2. Vá para o **Painel de Decisões**.
3. Para cada item, leia as **opções explicadas** (o que cada escolha significa na prática: quais telas, qual fluxo, o que o usuário vê).
4. Marque os checkboxes para registrar decisões.
5. No final, responda as perguntas de debate de forma mais concreta.

Depois de decidir, consolidamos em `tema-escolhido.md`, `decisoes.md` e atualizamos o protótipo/fluxograma.

1. Contexto Rápido (Problematização)

Fonte principal da problematização (12/06):

A contextualização completa e fundamentada com referências da literatura foi elaborada por **Rios** e está consolidada em:

 [problema-real.md](#)

(Material-fonte: `material-fonte/Projeto-Algorit-1-Rios-2026-06-12.docx`)

O texto usa consistentemente o termo “**fila presencial**” (para diferenciar das listas de espera de meses que aparecem na literatura). O grupo pode alterar ou sugerir adequações conforme o autor autorizou.

O fluxo oficial de urgência/emergência tem um “buraco” entre o guichê (ordem de chegada) e a triagem (Protocolo de Manchester). Isso gera sensação de arbitrariedade e injustiça.

Pergunta de pesquisa central (Rios):

Como reduzir o tempo de permanência física dos usuários nas unidades de saúde e aumentar a previsibilidade do atendimento por meio de uma solução digital acessível e inclusiva?

Cores do Protocolo de Manchester (para referência):

- **Vermelho** — Emergência (0 min)
- **Laranja** — Muito urgente (até 10 min)
- **Amarelo** — Urgente (até 60 min)
- **Verde** — Pouco urgente (até 120 min) — ~70% dos casos
- **Azul** — Não urgente (até 240 min)

Identidade Visual e Cores Oficiais

Arquivo dedicado: [Identidade-visual.md](#)

(Crie/popule esse arquivo com as cores hex exatas, tipografia e padrões que o grupo definir. Todos devem seguir rigorosamente o que estiver lá. Atualizaremos futuramente com as definições finais.)

2. Identidade Visual (Contexto Correto)

A identidade visual ainda está em definição. Precisamos alinhar **agora** para que slides, protótipo Figma e documentação usem a mesma linguagem.

O que precisamos decidir nesta semana:

- Cores exatas do Protocolo de Manchester (HEX).
- Cores adicionais do app (neutras, botões, fundos, alertas).
- Tipografia (fonte legível, tamanhos para acessibilidade).
- Estilo de ícones e ilustrações (simples, alto contraste, ou mais moderno?).
- Modos de acessibilidade visuais (alto contraste, baixo estímulo para TEA, versão grande fonte).

Recomendação: Alguém do grupo (quem for fazer o Figma ou os slides) deve popular o arquivo `Identidade-visual.md` com as definições escolhidas. Depois, todo mundo referencia esse arquivo como fonte única.

3. Painel de Decisões — Com Opções Explicadas (O Que Cada Escolha Significa na Prática)

Cada item agora tem explicação de **como ficaria o fluxo e as telas** dependendo da escolha.

Marque [x] conforme o grupo for decidindo.

3.1 Integração com sistemas oficiais do Governo (Meu SUS Digital / RNDS)

O que isso significa na prática:

- **Opção A (Integração forte):** O app pede login com Gov.br / Meu SUS Digital. Puxa automaticamente: nome, CPF, alergias conhecidas, deficiências cadastradas, histórico de atendimentos. O paciente só confirma ou corrige. Reduz muito a digitação.
- **Opção B (Fallback manual forte):** Oferece login Gov.br como opcional. Se a pessoa não tiver ou não quiser, faz cadastro simples (nome + CPF/SUS + telefone + perguntas de acessibilidade). Mais inclusivo para quem não tem conta digital.
- **Opção C (Visão futura apenas):** Mencionamos a integração como “poderia fazer no futuro”, mas no protótipo atual fazemos só cadastro manual.

Telas que mudam conforme a escolha: - Tela de “Entrar” / “Cadastrar”. - Tela de “Meus dados” (mais ou menos pré-preenchida).

☐

A proposta **se apoia** em integração com governo

☐

Vamos **incluir** integração real no protótipo/entrega (Opção A)

☐

Vamos priorizar cadastro manual + login Gov.br opcional (Opção B — mais inclusivo)

☐

Vamos mencionar como **visão futura** (Opção C)

☐

Vamos **remover** qualquer menção forte a integração por enquanto

3.2 Cadastro alternativo sem conta Gov.br + Perguntas de Acessibilidade

Como pode ser na prática:

- **Versão mínima:** Nome, CPF/SUS, telefone, “Tem alguma deficiência ou necessidade especial?” (sim/não).
- **Versão rica (recomendada):** Checkbox ou cards com: Deficiência auditiva, visual, motora, TEA, idoso, gestante, criança pequena acompanhando, etc. + campo “Precisa de algum apoio específico?” (texto livre).
- **Fluxo de impacto:** Se marcar TEA ou auditiva, o sistema pode:
 - Sugerir “Modo Baixo Estímulo” no app.
 - Enviar alerta visual + vibração (sem som).
 - Avisar a equipe internamente (“Paciente com TEA — preferir sala mais silenciosa”).

Telas envolvidas: - Tela de Cadastro (1 ou 2 passos). - Tela “Minha fila” com banner de acessibilidade ativado. - Painel da recepção com tag de necessidade especial.

☐

A proposta **se apoia** em oferecer cadastro manual detalhado

☐

Vamos **incluir** perguntas específicas de deficiência + impacto no fluxo (TEA, auditiva, etc.)

☐

Vamos fazer cadastro simples só com nome + contato (sem foco em acessibilidade no cadastro)

☐

Vamos prototipar telas diferentes dependendo da deficiência marcada

3.3 Cor provisória gerada pelo app (antes da triagem oficial)

Opções reais de como mostrar:

- **Opção A (Transparente com paciente):** O app faz uma classificação inicial baseada nas respostas do cadastro + sintomas. Mostra ao paciente uma cor provisória grande na tela com texto bem claro: “Isso é uma estimativa automática. A triagem oficial pode mudar sua cor.”
- **Opção B (Interno apenas):** O app calcula a cor e mostra só para a equipe no painel interno. Paciente vê só posição e tempo estimado.
- **Opção C (Sem cor provisória):** Não fazemos nenhuma estimativa. Só mostramos ordem de chegada + tempo médio histórico.

Telas impactadas: - Tela “Sua posição na fila”. - Painel da recepção.

☐

- ☐ A proposta **se apoia** em gerar cor provisória
- ☐ Vamos mostrar a cor provisória **visível ao paciente** com aviso claro (Opção A)
- ☐ Vamos usar cor provisória **apenas internamente** (Opção B)
- ☐ Vamos **não usar** cor provisória por enquanto (Opção C)

3.4 Transparência no painel (mostrar cores e posição das pessoas na frente)

Como pode ficar visualmente:

- **Opção A (Alta transparência):** Lista com bolinhas coloridas + posição aproximada. Exemplo: “3 pessoas na frente (2 Verde, 1 Amarelo)”. Sem nomes.
- **Opção B (Média):** Mostra só “Você é o 7º” + tempo estimado. Sem mostrar cores das outras pessoas.
- **Opção C (Testar duas versões no protótipo):** Uma versão com transparência de cores, outra mais discreta, e ver qual o grupo prefere.

Telas: - Tela do paciente “Minha fila”. - Painel grande na recepção (o que todo mundo vê).

- ☐ A proposta **se apoia** em mostrar cores das pessoas na frente
- ☐ Vamos **incluir** transparência de cores no protótipo (Opção A)
- ☐ Vamos mostrar apenas posição + tempo (Opção B)
- ☐ Vamos prototipar as duas versões para comparar (Opção C)

3.5 Sair do local e ser avisado (saída temporária)

Fluxo possível:

Paciente marca “Vou sair um pouco”. O app continua acompanhando a fila. Quando faltarem X pessoas ou X minutos, envia notificação push + vibração + banner na tela (mesmo com o app fechado).

Variações: - Notificação só quando faltar 1-2 pessoas. - Notificação em dois estágios (ex: “Faltam ~15 min” e depois “Sua vez está chegando”). - Opção de “voltar para o final da fila” se perder a chamada.

- ☐ A proposta **se apoia** nessa funcionalidade
- ☐ Vamos **incluir** saída temporária + notificação no protótipo

- ☐ Vamos mencionar como ideia futura (sem prototipar agora)
- ☐ Vamos remover por enquanto

3.6 Tela pós-atendimento (resumo, medicamentos, próximos passos)

O que pode aparecer:

- “Você foi atendido(a)”.
- Lista de medicamentos prescritos (se o sistema tiver integração futura) ou campo manual.
- “Próximos passos”: voltar em X dias, fazer exame, etc.
- Botão “Avaliar o atendimento” (simples, 1-5 estrelas + comentário rápido).
- Versão acessível com áudio ou texto grande.
- ☐ A proposta **se apoia** em incluir tela pós-consulta
- ☐ Vamos **incluir** resumo + lembretes com foco em acessibilidade (idosos/TEA)
- ☐ Vamos focar só até a fila de consulta (sem pós-atendimento no protótipo)
- ☐ Vamos deixar como extensão futura

4. Possíveis Fluxos Completos do App (para ajudar na decisão)

Fluxo 1 — Mais simples (recomendado para protótipo inicial) Chegada → Cadastro simples → Entra na fila → Acompanha posição + tempo + notificação → Vai para triagem.

Fluxo 2 — Com transparência alta Mesmo do Fluxo 1 + mostra cores das pessoas na frente + opção de sair temporariamente.

Fluxo 3 — Com acessibilidade forte Cadastro com perguntas de deficiência → ativa automaticamente “Modo Baixo Estímulo” ou “Modo Alto Contraste” → equipe recebe tag interna → paciente vê interface adaptada.

Podemos prototipar um fluxo principal e mencionar variações.

5. Mapa Sugerido de Telas (para referência do protótipo)

Possíveis telas (não todas precisam ser feitas agora):

1. **Tela de Boas-vindas / QR Code**
2. **Cadastro** (1 ou 2 passos, com ou sem perguntas de acessibilidade)

3. **Minha Fila** (posição, tempo estimado, cor provisória?, banner de acessibilidade)
 4. **Detalhes da Fila** (pessoas na frente com cores — opcional)
 5. **Notificação / Alerta de chamada**
 6. **Painel da Recepção** (visão da equipe)
 7. **Tela Pós-atendimento** (resumo)
 8. **Configurações de Acessibilidade** (alto contraste, tamanho de fonte, modo silencioso)
-

6. Nomes Sugeridos

(Mantive a seção original, mas podemos votar depois de definir o escopo.)

Transparência e Clareza

- ☐ **FilaClara**
- ☐ **FilaTransparente**
- ☐ **ClaraFila**
- ☐ **FilaAberta**

Acessibilidade e Inclusão

- ☐ **FilaAcessível**
- ☐ **AcessaFila**
- ☐ **FilaInclusiva**
- ☐ **FilaParaTodos**

Nomes modernos / App

- ☐ **FilaLivre**
- ☐ **AppFila**
- ☐ **FilaAgora**
- ☐ **Fil.Ai**
- ☐ **Filei**

7. Perguntas para Debate (mais coesas e ligadas às escolhas)

1. Qual fluxo principal vamos prototipar primeiro (Fluxo 1, 2 ou 3 descritos acima)? Por quê?
2. Vamos mostrar cor provisória ao paciente ou só internamente? Qual o risco de mostrar e a triagem mudar?
3. Qual o nível de transparência que queremos no painel (mostrar cores das pessoas na frente ou só posição + tempo)? Isso muda a sensação de justiça?
4. Cadastro com perguntas de deficiência vai ser obrigatório ou opcional? Como evitamos que a pessoa se sinta “obrigada a se declarar”?
5. Vamos priorizar integração com Gov.br desde o começo ou focar primeiro em cadastro manual acessível?
6. Quais telas são **obrigatórias** no protótipo mínimo viável e quais são “bônus”?
7. Quem vai ser responsável por definir as cores HEX e popular o arquivo `Identidade-visual.md` esta semana?

Base oficial do problema (integrada 12/06):

 Leia primeiro o texto completo com fundamentação em literatura: [problema-real.md](#)

(Material-fonte: `material-fonte/Projeto-Algorit-1-Rios-2026-06-12.docx`)

Ação imediata para o grupo (12/06): 1. Leiam o texto completo do problema em [problema-real.md](#) (é a base oficial, com todas as referências da literatura que Rios usou). 2. Vão direto para o **Painel de Decisões** abaixo e marquem as opções (integração Gov.br, cor provisória, transparência, saída temporária etc.). 3. Votem nos nomes sugeridos (seção 3). 4. Tragam sugestões de alteração no texto do problema (Rios autorizou: “fiquem à vontade para alterar ou sugerir adequações”). 5. O checklist completo e o lembrete do chat (“depois de fazer o seu arquivo...”) estão no final deste documento.

2. Painel de Decisões — Caminho Linear

Base para todas as decisões abaixo:

O problema real foi definido por Rios em 12/06/2026 com fundamentação em literatura.

 Leia primeiro: [problema-real.md](#) (e o material-fonte original).

Todas as escolhas (integração, cor provisória, transparência, acessibilidade, etc.) devem responder à pergunta central:

“Como reduzir o tempo de permanência física dos usuários nas unidades de saúde e aumentar a previsibilidade do atendimento por meio de uma solução digital acessível e inclusiva?”

Cada item abaixo tem: - Breve explicação - **Se apoia na proposta?** (a ideia faz sentido para nós?) - **Incluir na entrega?** (vamos levar para protótipo, slides, documentação?)

Marque [x] conforme o grupo for decidindo.

2.1 Integração com sistemas oficiais do Governo (Meu SUS Digital / RNDS)

A proposta menciona possibilidade de puxar dados automaticamente (alergias, histórico, deficiências) para reduzir repetição e melhorar o acolhimento.

- ☐ A proposta **se apoia** em integração com governo
- ☐ Vamos **incluir** integração real no protótipo/entrega
- ☐ Vamos mencionar como **visão futura** (sem implementar agora)
- ☐ Vamos **remover** qualquer menção forte a integração por enquanto (deixar em aberto)

Status atual (12/06): Problema real definido e fundamentado em literatura (ver [problema-real.md](#) + material-fonte). Todas as decisões abaixo devem responder à pergunta central de Rios.

2.2 Cadastro alternativo sem conta Gov.br

Permite que o paciente informe nome, CPF, deficiências, alergias e sintomas de forma simples.

- ☐ A proposta **se apoia** em oferecer cadastro manual
- ☐ Vamos **incluir** cadastro manual completo no protótipo
- ☐ Vamos priorizar apenas Meu SUS Digital + fallback simples
- ☐ Vamos deixar cadastro manual como item secundário

2.3 Módulo forte de Acessibilidade (TEA, auditiva, visual)

Perguntas específicas no cadastro + preparação da equipe antes da chegada (modo baixo estímulo, recursos visuais, etc.).

- ☐ A proposta **se apoia** em acessibilidade como diferencial central
- ☐ Vamos **incluir** perguntas de deficiência e modos acessíveis no protótipo
- ☐

Vamos tratar acessibilidade de forma mais genérica (sem ênfase forte em TEA)

☐

Vamos prototipar telas específicas para diferentes tipos de deficiência

2.4 Uso de “cor provisória” gerada pelo app

O app faria uma classificação inicial antes da triagem oficial.

☐

A proposta **se apoia** em gerar cor provisória

☐

Vamos **incluir** cor provisória visível ao paciente (com aviso claro de que é temporária)

☐

Vamos usar cor provisória apenas internamente (não mostrar ao paciente)

☐

Vamos **remover** o conceito de cor provisória por enquanto

2.5 Transparência radical no painel (mostrar cores das pessoas na frente)

Mostrar posição + cores das pessoas à frente (sem nomes).

☐

A proposta **se apoia** em mostrar cores no painel

☐

Vamos **incluir** cores das pessoas na frente no protótipo

☐

Vamos mostrar apenas posição + tempo estimado (sem cores)

☐

Vamos testar as duas versões

2.6 Opção de sair do local e ser avisado (saída temporária)

Paciente pode sair e receber alerta quando estiver próximo.

☐

A proposta **se apoia** nessa funcionalidade

☐

Vamos **incluir** no protótipo

☐

Vamos mencionar como ideia futura

☐

Vamos remover por enquanto

2.7 Lembretes de medicamento e resumo pós-consulta

Tela final com medicamentos + próximos passos.

☐

A proposta **se apoia** em incluir pós-consulta

- ☐ Vamos **incluir** no protótipo (foco em acessibilidade para idosos/TEA)
 - ☐ Vamos focar só até a fila de consulta
 - ☐ Vamos deixar como extensão futura
-

3. Nomes Sugeridos (apresentação visual clara e coesa)

Instruções: Cada pessoa marque [x] em até 3 nomes que mais gostar. Depois fazemos votação rápida.

Transparência e Clareza

- ☐ **FilaClara**
- ☐ **FilaTransparente**
- ☐ **ClaraFila**
- ☐ **FilaAberta**

Acessibilidade e Inclusão

- ☐ **FilaAcessível**
- ☐ **AcessaFila**
- ☐ **FilaInclusiva**
- ☐ **FilaParaTodos**

Agilidade e Justiça

- ☐ **FilaRápida**
- ☐ **PriorizaFila**
- ☐ **FilaJusta**
- ☐ **FilaSegura**

Nomes modernos / App

- ☐ **FilaLivre**
- ☐

- ☐ **AppFila**
- ☐ **FilaAgora**
- ☐ **FilaDireta**
- ☐ **FilaViva**
- ☐ **SaudeFila**

Sugestões recentes do chat: - [] Filei - [] Fil.Ai - [] AppFila

4. Identidade Visual e Cores do Protocolo de Manchester

Arquivo dedicado: [Identidade-visual.md](#)

(Crie, popule e mantenha esse arquivo. Defina as cores hex exatas do Manchester + estilos de acessibilidade. Todos devem seguir o padrão definido lá.)

Status: Arquivo ainda não preenchido. Atualizaremos com as definições do grupo.

5. Perguntas para Debate pelo Grupo

1. Quais são os requisitos necessários para a integração com o governo (Meu SUS Digital / RNDS)?
 2. Como podemos validar se as demandas do PDF estão alinhadas com a proposta?
 3. Quais critérios devemos usar para marcar os checkboxes de aprovação?
 4. De que forma a decisão sobre cada item impactará o cronograma do projeto?
 5. Quem será responsável por acompanhar a implementação das escolhas feitas?
-

Próximo passo (consolidado 12/06 após integração do problema de Rios):

- Leiam o texto completo em [problema-real.md](#) (é a base oficial da problematização, com todas as referências da literatura).
- Marquem as opções no Painel de Decisões acima (integração Gov.br, cor provisória, transparência, saída temporária, pós-atendimento).
- Votem nos nomes (seção 3).
- Tragam sugestões de alteração ou adequações no texto do problema (Rios pediu explicitamente: “fiquem à vontade para alterar ou sugerir adequações”).

- Depois consolidamos tudo em uma versão limpa da proposta para a apresentação de 29/06.

Lembrete do chat: depois que o arquivo do problema foi feito, a próxima pessoa faz o dela, e o grupo revisa coletivamente “o que ele passou nessa proposta e qual foi de fato a fala”.

 Relatório original da Ausiane:
relatorio_filas_inteligentes.pdf
 Problema real completo (Rios, 12/06): [problema-real.md](#) +
material-fonte/Projeto-Algorit-1-Rios-2026-06-12.docx
 Google Docs de pesquisa/casos: no [Index-Geral.md](#)

Documento vivo. Base do problema agora é oficial e ancorada. Editem e marquem decisões.